



治疗双相障碍的药物

作者: [William Coryell](#), MD, University of Iowa Carver College of Medicine

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 1月 2026

选择治疗[双相障碍](#)的药物可能很困难，因为所有药物都有副作用，药物相互作用很常见，没有药物对每个人都有效。

医生根据患者过去的健康状况（如果病史已知且包括双相障碍的先前治疗）以及根据患者已知的病史、哪些药物可能有效来选择药物。医生也会小心避免开具过去曾引起严重并发症或症状的药物处方，或根据患者目前的健康状况而可能造成这种威胁的药物处方。

(另见[双相障碍的治疗](#)。)

心境稳定剂

双相障碍中用作情绪稳定剂的药物包括锂和某些抗癫痫药物。

锂

锂能减轻躁狂和抑郁的症状，尤其是有双相障碍家族史的人。锂盐可帮助很多双相障碍患者预防情绪波动。锂盐需服用 4~10 天后才开始起效，因此常需联合快速起效的药物，如抗癫痫药物或新一代（第二代）抗精神病药物，以便于控制思维和行动活跃。有典型双相障碍家族史的人更容易对锂盐产生应答。

锂盐可导致副作用。它的副作用包括困倦、困惑、不自主震颤、肌肉抽搐、恶心、呕吐、腹泻、口渴、尿频和体重增加。它常可导致痤疮或牛皮癣加重。这些副反应常持续时间短，可以通过调整剂量减轻症状。

临床使用锂盐时必需监测锂盐的血药浓度，因为其血浓度越高，发生药物副反应的可能越大。长期服用锂盐可导致甲状腺激素水平下降（[甲状腺功能减退](#)），也可损害肾功能。因此，服用锂盐的患者需要定期监测甲状腺功能和肾功能，并使用最低剂量。

锂中毒发生于血液中的锂水平非常高时。表现为持续性头痛、精神错乱、困倦、癫痫发作和心律失常。毒性更可能发生在以下情况中：

- 老年人
- 肾功能受损的患者
- 因呕吐、腹泻或使用利尿药（使肾脏排泄更多的钠和水）失钠过多的人群

抗惊厥药

抗癫痫药物**丙戊酸**和**卡马西平**可作为心境稳定剂。它们可用于治疗首次发作的躁狂，或用于治疗躁狂和抑郁的同时发作（混合型发作）。与锂盐不同，这类药物不损伤肾功能。不过，卡马西平可显著减少红细胞和白细胞数量。丙戊酸可引起肝损伤（主要在儿童患者）或严重的胰腺损伤。通过密切监测各种生化指标，医师可及时发现由药物引起的不良反应。丙戊酸一般不能用于已怀孕或处于生育年龄的女性双相障碍患者，因为它们似乎可增加胎儿的脑或脊髓出生缺陷（**神经管缺陷**）、**注意力缺陷/多动症**及**自闭症**风险。丙戊酸和卡马西平可能有用，尤其对于那些经其他药物治疗无效的患者。

拉莫三嗪有时用于帮助控制心境波动和治疗抑郁。拉莫三嗪可引起严重的皮疹。少数情况下，皮疹可演变成危及生命的**Stevens-Johnson 综合征**。服用拉莫三嗪的患者应密切注意新皮疹（特别是直肠和生殖器周围的皮疹）、发烧、腺体肿胀、口腔内或眼睛上的水疱性溃疡以及嘴唇或舌头肿胀的发生。出现这些症状时应报告给医生。为减少这些症状的发生风险，医生会严格遵循建议的方案上调剂量。初始给药时采用相对较低的剂量，然后以极慢的速度（数周时间）增加至建议的维持剂量。如果中间停药 3 天或以上，必须重新按照建议方案缓慢上调剂量。

抗精神病药物

因第二代**抗精神病药物**相较于其他治疗双相障碍的药物，起效迅速且副反应少，所以正逐渐被用于治疗突然的狂躁发作。这些药物包括阿立哌唑、阿塞那平、卡利哌隆、鲁马特哌隆、鲁拉西酮、奥氮平、帕利哌酮、喹硫平、利培酮和齐拉西酮。

对于**双相抑郁症**，某些抗精神病药物可能是最好的选择。有的患者需要使用抗抑郁药物。

长期使用抗精神病药物的副反应可见体重增加和**代谢综合征**。代谢综合征主要表现为腹部脂肪过多合并胰岛素敏感度下降（胰岛素抵抗）、高血糖、胆固醇水平异常和高血压。然而，阿立哌唑和齐拉西酮则很少引起代谢综合征。有时在怀孕期间会开具第一代和第二代抗精神病药，但利培酮除外，此药会略微增加出生缺陷的风险。

抗抑郁药

某些抗抑郁药（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂[SSRI]）有时用于治疗双相障碍患者的重度抑郁，但其使用仍存在争议。因此，这类药物仅用于短期治疗，及与某种心境稳定剂或非典型抗精神病药物联合使用。

孕期注意事项

计划怀孕或已怀孕的双相障碍患者应该去看精神病科医生，他们具有在孕期治疗精神疾病的专门知识。怀孕前去医生那里很重要，因为一些用于治疗双相障碍的药物会导致出生缺陷。在孕前或妊娠早期就诊时，医生会回顾当前和过去的药物和当前症状，讨论风险和益处，并可能改变药物以确保患者和胎儿的健康和安全。（另见**妊娠期使用抗抑郁药**。）

抗惊厥药

卡马西平和**丙戊酸钠**导致出生缺陷的风险最高，在怀孕期间应避免使用。作为预防措施，医生将制定计划，在任何计划怀孕之前改用其他药物。有关这些药物风险的更多详情：

- **丙戊酸**会增加[神经管缺陷](#)(如[脊柱裂](#))和异常（面部和颅骨、四肢、心脏和其他心血管结构）的风险。它也与 IQ 评分低和[孤独症谱系障碍](#)有关。一些国家禁止在妊娠期间使用其治疗双相障碍。
- **卡马西平**也会增加神经管缺陷的风险，但在某些情况下（例如，当孕妇需要治疗癫痫时）可使用。

通常认为妊娠期使用**拉莫三嗪**比使用丙戊酸钠或卡马西平更安全。

锂

孕期使用**锂**与一种称为埃布斯坦畸形的特定类型的心血管出生缺陷的风险增加有关。然而，由于这种风险相当低，因此有时在妊娠期间以尽可能低的剂量继续使用锂盐。

抗精神病药物

到目前为止，在妊娠早期使用第一代抗精神病药物和三环类抗抑郁药尚未引起安全担忧。有证据表明，大多数非典型（第二代）抗精神病药物在妊娠期间使用通常是安全的，但喹硫平、阿立哌唑、奥氮平和利培酮可能会略微增加风险。

抗抑郁药

[选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂](#) (SSRI) 导致出生缺陷的风险也较低。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[抑郁症和双相障碍支持联盟 \(DBSA\)，双相障碍](#)

[美国心理卫生协会 \(MHA\)，双相障碍](#)

[全国心理疾病联盟 \(NAMI\)，双相障碍](#)

[国家精神卫生研究所 \(NIMH\)，双相障碍](#)